



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
KOMITE KEPERAWATAN
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2025 telah menjadi dasar penting dalam penguatan tata kelola keperawatan di rumah sakit. Selama tahun 2025, Komite Keperawatan bersama Sub Komite Kredensial, Mutu Keperawatan, serta Etik dan Disiplin telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemenuhan regulasi, penataan kewenangan klinis, pelaksanaan kredensial dan rekredensial perawat, peningkatan mutu pelayanan, serta pembinaan etik dan profesionalisme keperawatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan dan mendukung operasional pelayanan keperawatan. Namun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesinambungan antara kegiatan kredensial, pelatihan, mutu pelayanan, dan pembinaan etik agar lebih terintegrasi dan berdampak langsung terhadap praktik klinis perawat.

Berdasarkan temuan tersebut, Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2026 disusun sebagai kelanjutan dan penguatan dari program kerja tahun sebelumnya, bukan sebagai perubahan arah kebijakan. Fokus pengembangan tahun 2026 diarahkan pada peningkatan integrasi antar sub komite melalui penyelarasan kewenangan klinis, pelatihan berbasis risiko pelayanan, monitoring mutu keperawatan, serta pembinaan etik yang terdokumentasi secara sistematis.

Sebagai bentuk peningkatan tata kelola, Program Kerja Tahun 2026 menekankan pemanfaatan logbook terintegrasi sebagai instrumen utama untuk menghubungkan proses kredensial, pelaksanaan praktik klinis, evaluasi mutu, penerapan etik, dan pengembangan kompetensi perawat secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga dapat ditelusuri dampaknya terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Dengan demikian, Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat kesinambungan pembinaan keperawatan, meningkatkan profesionalisme perawat, serta mendukung pencapaian mutu pelayanan rumah sakit secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB II

LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, setiap Rumah Sakit harus membentuk Komite Keperawatan.

Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan, yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan diberikan secara Benar , sesuai standar, sesuai kode etik profesi. Oleh tenaga keperawatan yg kompeten dgn kewenangan yg jelas.

Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku. Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang- kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua Komite Keperawatan
- b. Sekretaris Komite Keperawatan
- c. Subkomite :
 - a. Subkomite Kredensial
 - b. subkomite mutu profesi
 - c. subkomite etik dan disiplin profesi.

Hubungan komite keperawatan dengan pengelola rumah sakit yaitu komite Keperawatan merupakan kelompok profesi tenaga keperawatan dalam struktur fungsional berada di bawah kepala/direktur RS dan bertanggungjawab langsung kepada kepala/ direktur RS serta bekerja sama & berkoordinasi dgn kabid keperawatan serta saling memberikan masukan tentang perkembangan profesi keperawatan & kebidanan.

Harapan outputnya adalah komite keperawatan berjalan efektif dan efisien sehingga dapat menjamin perawat kompeten

BAB III

TUJUAN

A. TUJUAN

1. UMUM

Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit lebih terjamin dan terlindungi

2. KHUSUS

Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:

- a. Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit;
- b. Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi bidan dan perawat
- d. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan

BAB IV
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. KEGIATAN

- Program kerja Komite Keperawatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :
- 1. Melakukan Kredensial bagi tenaga perawat dan bidan
 - 2. Pembinaan etika perawat dan bidan
 - 3. Pengawasan mutu keperawatan dan kebidanan
 - 4. Meningkatkan kemampuan Staff Komite
 - 5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM
 - 6. Berkoordinasi dengan sub komite patient safety dan penjaminan mutu dalam peningkatan mutu pelayanan

B. RINCIAN KEGIATAN

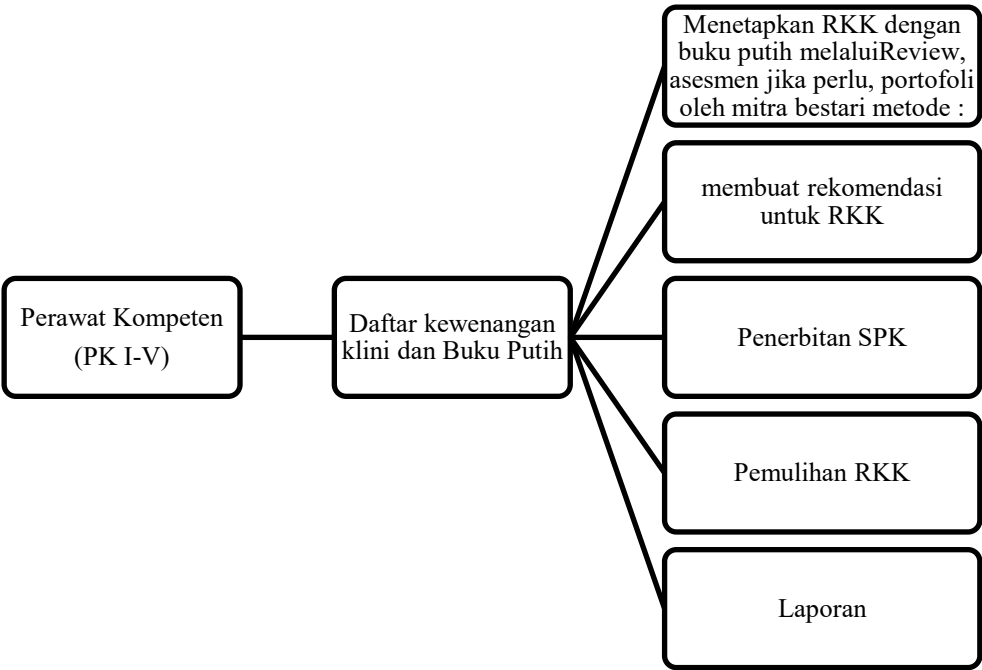
1. Subkomite Kredensial

Kredensial adalah proses verifikasi kompetensi seorang perawat yang selanjutnya ditetapkan kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan lingkup praktiknya.

Area Praktik (Scope of Practice) :

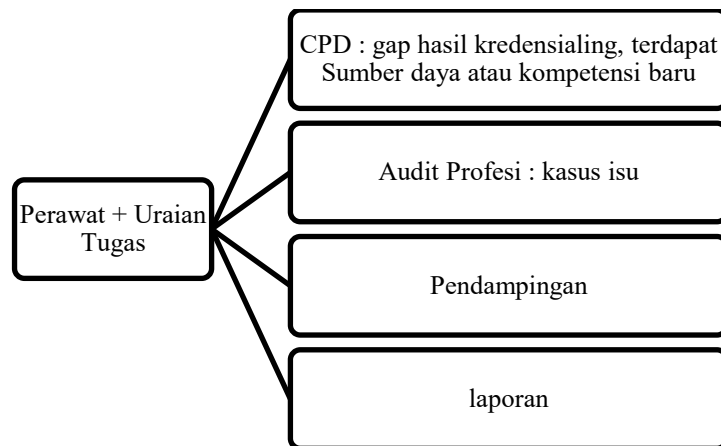
- 1. Parameter dari otoritas praktik yang dijamin oleh perawat melalui perizinan
- 2. Parameter dari kewenangan klinik yang diakui melalui surat penugasan klinik.

Lingkup Kerja Sub Komite Kredensialing



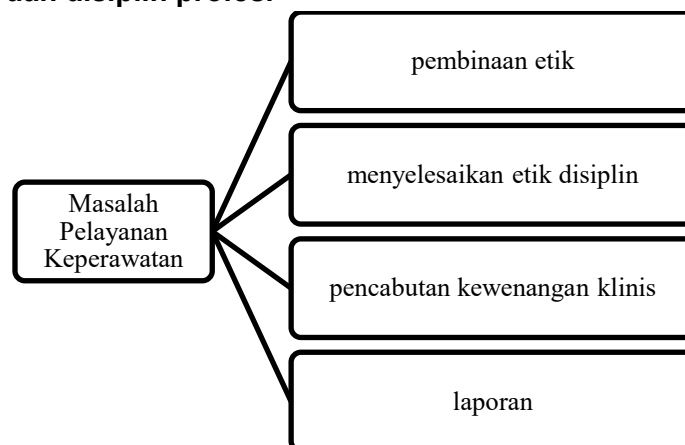
- a. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis Keperawatan dan Kebidanan
- b. Menyusun Pedoman Jenjang Karir
- c. Membuat Pemetaan Jenjang Karir
- d. Melakukan Kredensial secara berkala
- e. Berpartisipasi/ ikut serta dalam proses rekrutmen
- f. Melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada direktur Rumah sakit.

2. Subkomite Mutu dan Profesi



- Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai dengan praktik keperawatan
- Memastikan mutu pelayanan dengan tujuan keselamatan Pasien
- Update Informasi Pengetahuan dan Teknologi terkait Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan
- Standar Keperawatan terbaru
- Memastikan mutu pelayanan baik dengan tujuan keselamatan Pasien
- Menunjuk Asesor Kredensialing Keperawatan dan Kebidanan
- Merekomendasikan pelatihan keperawatan dan kebidanan untuk meningkatkan kemampuan
- Melakukan audit keperawatan dan kebidanan

3. Subkomite etik dan disiplin profesi



- Menyusun kode etik keperawatan
- Menyusun alur pelaporan pelanggaran kode etik
- Sosialisasi etik keperawatan
- Pembinaan perawat dan bidan
- Sosialisasi hak dan kewajiban perawat dan bidan
- Sosialisasi sanksi jika terjadi pelanggaran kode etik
- Menyusun buku pedoman etika
- Melakukan Evaluasi pembinaan etika

BAB III

CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
1. Audit, Investigasi, observasi, pengawasan dan pembinaan
 2. Melakukan pengolahan data
 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
 4. Menyusun perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya
 5. Rapat internal Komite Keperawatan
 6. Memberikan Rekomendasi kepada Direktur

BAB VI SASARAN

Tercapainya 80% pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan komite keperawatan dalam hal kredensial bagi perawat dan bidan di rumah sakit dan terlaksananya program komite keperawatan setiap tahunnya, hasil evaluasi kinerja tim komite keperawatan selalu dievaluasi dalam bentuk hasil laporan laporan yang telah dibuat setiap bulannya kepada ketua komite kemudian dilaporkan ke direktur langsung hasil capaian oleh sub komite sebagai bahan pertimbangan hasil kinerja sebelumnya dengan adanya program komite keperawatan.guna meningkatkan skill dan kemajuan SDM terutama dibagian perawat dan bidan dirumah sakit umum an nimah agar biasa dipercaya dan diakui kemampuan dalam hal pelayanan.

BAB VII

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan komite keperawatan yang dilakukan adalah kegiatan dalam rangka kredensial dan evaluasi pelaksanaan kredensial di rumah sakit yang secara garis besar meliputi:

1. Subkomite Kredensial
 - a. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis Keperawatan dan Kebidanan
 - b. Menyusun Pedoman Jenjang Karir
 - c. Membuat Pemetaan Jenjang Karir
 - d. Melakukan Kredensial secara berkala
 - e. Berpartisipasi/ ikut serta dalam proses rekrutmen
 - f. Melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada direktur Rumah sakit
2. Subkomite Mutu dan Profesi
 - a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai dengan praktik keperawatan
 - b. Memastikan mutu pelayanan dengan tujuan keselamatan Pasien
 - c. Update Informasi Pengetahuan dan Teknologi terkait Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan
 - d. Standar Keperawatan terbaru
 - e. Memastikan mutu pelayanan baik dengan tujuan keselamatan Pasien
 - f. Menunjuk Asesor Kredensialing Keperawatan dan Kebidanan
 - g. Merekomendasikan pelatihan keperawatan dan kebidanan untuk meningkatkan kemampuan
 - h. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan
3. Subkomite etik dan disiplin profesi
 - a. Menyusun kode etik keperawatan
 - b. Menyusun alur pelaporan pelanggaran kode etik
 - c. Sosialisasi etik keperawatan
 - d. Pembinaan perawat dan bidan
 - e. Sosialisasi hak dan kewajiban perawat dan bidan
 - f. Sosialisasi sanksi jika terjadi pelanggaran kode etik
 - g. Menyusun buku pedoman etika
 - h. Melakukan Evaluasi pembinaan etika

JADWAL KERJA PROGRAM KOMITE KEPERAWATAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Sosilalisasi Program Kerja 2026													Ketua
6	Pelatihan Asesor Kredensialing													Subkomite Kredensial
7	Proses kredensial mulai perawat baru dan rekredensial													Subkomite Kredensial
10	Pencatatan dan analisa pelaporan dan tindak lanjut komite keperawatan													Tim Komite
11	Pencatatan dan pelaporan audit keperawatan													Subkomite mutu dan profesi
12	Pemantauan kinerja staf komite													Ketua
13	Rapat Komite													Tim Komite
14	Laporan bulanan													Tim Komite
15	Laporan triwulanan													Tim Komite
16	Laporan tahunan													Tim Komite
17	Evaluasi hasil kerja tahun 2026													Tim Komite
18	Pembuatan program kerja 2026													Tim Komite

KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN BERDASARKAN SUB KOMITE

A. SUB KOMITE KREDENSIAL

No	Program / Kegiatan	Sub Komite	Tujuan	Bukti Pelaksanaan	Status
1	Penyusunan & Revisi Dokumen Kredensial	Kredensial	Pemenuhan regulasi	SOP, kebijakan	Sudah berjalan
1	Penyusunan & Revisi Dokumen Kredensial	Kredensial	Pemenuhan regulasi	SOP, kebijakan	Sudah berjalan
1	Review Kewenangan Klinis Perawat	Kredensial	Penyelarasan praktik klinis	Draft SK, logbook	Sedang berjalan
2	Kredensial & Rekredensial Perawat	Kredensial	Menetapkan kewenangan klinis	SK PK, BA kredensial	Sedang berjalan
4	Audit Kepatuhan Kewenangan Klinis	Kredensial	Keselamatan pasien	Form audit	Sedang berjalan
13	Rekredensial Perawat Berbasis Logbook	Kredensial	Akurasi kewenangan klinis	SK PK terbaru	Akan berjalan
3	Drill Keterampilan Klinis: Pemasangan Infus	Kredensial & Mutu	Keamanan & ketepatan tindakan	Checklist kompetensi & logbook	Prioritas
4	Drill Keterampilan Klinis: Pemasangan Kateter	Kredensial & Mutu	Pencegahan infeksi & keselamatan pasien	Form observasi & logbook	Prioritas
5	Drill Keterampilan Klinis: Pemasangan NGT	Kredensial & Mutu	Ketepatan prosedur & keselamatan	Checklist kompetensi	Prioritas
6	Drill Keterampilan Klinis: Plebotomi	Kredensial & Mutu	Keakuratan & pencegahan komplikasi	Form penilaian & logbook	Prioritas

B. MUTU

No	Program / Kegiatan	Sub Komite	Tujuan	Bukti Pelaksanaan	Status
3	Audit Dokumentasi Keperawatan	Mutu	Evaluasi mutu praktik	Laporan audit	Sudah berjalan
4	Monitoring Indikator Mutu Keperawatan	Mutu	Peningkatan mutu layanan	Laporan indikator	Sudah berjalan
3	Audit Dokumentasi Keperawatan	Mutu	Evaluasi mutu praktik	Laporan audit	Sudah berjalan
4	Monitoring Indikator Mutu Keperawatan	Mutu	Peningkatan mutu layanan	Laporan indikator	Sudah berjalan

3	Pelatihan Klinis Prioritas (ACLS, EWS, TRIAGE)	Mutu	Peningkatan kompetensi	Jadwal, modul	Sedang berjalan
1	Pelatihan Early Warning System (EWS)	Mutu	Deteksi dini perburukan pasien	Sertifikat & post-test	Prioritas
2	Pelatihan Triage IGD	Mutu	Ketepatan prioritas emergensi	Sertifikat & evaluasi	Prioritas
7	Monitoring Implementasi EWS di Unit Rawat Inap	Mutu	Kepatuhan praktik	Laporan monitoring	Akan berjalan
8	Monitoring Implementasi Triage di IGD	Mutu	Keselamatan pasien	Laporan evaluasi	Akan berjalan
9	Audit Mutu Keperawatan Terintegrasi	Mutu	Peningkatan praktik	Laporan audit	Akan berjalan

C. ETIK DAN DISIPLIN

No	Program / Kegiatan	Sub Komite	Tujuan	Bukti Pelaksanaan	Status
5	Sosialisasi Etik & Disiplin Keperawatan	Etik	Peningkatan profesionalisme	Daftar hadir	Sudah berjalan
6	Penanganan Kasus Etik Keperawatan	Etik	Pembinaan profesi	Notulen kasus	Sudah berjalan
5	Sosialisasi Etik & Disiplin Keperawatan	Etik	Peningkatan profesionalisme	Daftar hadir	Sudah berjalan
6	Penanganan Kasus Etik Keperawatan	Etik	Pembinaan profesi	Notulen kasus	Sudah berjalan
10	Evaluasi Etik Keperawatan Berkala	Etik & Disiplin	Profesionalisme	Laporan pembinaan	Akan berjalan
5	Penyusunan Logbook Terintegrasi	Komite Keperawatan	Integrasi kredensial– mutu–etik	Draft logbook	Sedang berjalan
11	Pelaporan Terintegrasi ke Manajemen	Komite Keperawatan	Tata kelola RS	Laporan tahunan	Akan berjalan

12	Implementasi Logbook Terintegrasi	Komite Keperawatan	Integrasi kredensial– mutu–etik	Logbook aktif	Akan berjalan
----	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------	---------------

BAB VIII

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Ketua Komite Keperawatan melakukan pencatatan dan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Periode evaluasi program dilaksanakan setiap Triwulan. Sedangkan laporan menyeluruh tentang keberhasilan dan pencapaian program maupun kendala dan permasalahan yang dihadapi dituangkan dalam Laporan Tahunan Komite Keperawatan sebagai bahan masukan bagi manajemen yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan keperawatan dan pengembangan rumah sakit kedepan

- a. Sistem pelaporan data dilakukan sebagai berikut:
 1. Masing-masing sub melaporkan hasil setiap 1 bulan sekali kepada ketua komite
 2. Ketua komite membuat analisa dari hasil yang sudah dilaporkan dari masing masing sub komite
 3. Pembuatan analisa
- b. Analisa dilakukan dengan hasil capaian proses kredensial dari masing –masing subkomite. Analisa dilakukan setiap 3 bulan oleh komite . Analisa dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Membandingkan secara internal yaitu dengan bulan sebelumnya
 - 2) Membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan pada tingkat rumah sakit
 - 3) Membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan pada tingkat nasional
 - 4) Membandingkan hasil kredensial rumah sakit dengan rumah sakit lain yang setipe (jika memungkinkan)
 - 5) Pelaporan oleh komite mutu dilakukan 3 bulan sekali terkait hasil capaian komite rumah sakit. Pelaporan dilakukan langsung pada Direktur. Laporan dibuat oleh sekretaris komite keperawatan dan diserahkan pada ketua komite rumah sakit
 - 6) Laporan kepada direktur dilakukan langsung oleh komite keperawatan
 - 7) Laporan dilakukan setiap 3 bulan sekali terkait hasil kredensial rumah sakit.
 - 8) Laporan dibuat secara tertulis dalam bentuk uraian data statistik, grafik ataupun laporan dalam bentuk tabel disertai analisa hasil capaian kredensial.
 - 9) Membuat rencana tindak lanjut
Rencana tindak lanjut merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian pelayanan. Rencana tindak lanjut dibuat setiap 3 bulan setelah hasil capaian dilaporkan ke Direktur.
 - 10) Evaluasi dan monitoring hasil capaian kredensial rumah sakit dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Evaluasi dan monitoring hasil secara langsung dari direktur pada unit kerja dilakukan melalui rapat manajemen setiap bulannya.

BAB VII PENUTUP

Bidang Pelayanan Keperawatan bertanggung jawab dalam pengelolaan mutu pelayanan keperawatan di RS dan penerapan standar pelayanan. Komite Keperawatan sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan keperawatan dan menjamin Kompetensi perawat oleh rumah sakit. Komite keperawatan memberikan jaminan profesionalisme tenaga keperawatan.

Demikian program kerja Komite Keperawatan Rumah sakit Prima Husada Malang ini disusun, dengan harapan dengan adanya program kerja ini, dapat dipakai sebagai program kerja dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Malang

Malang, 10 Januari 2026

Dilaporkan Kepada,

Ketua Komite Keperawatan



Fariz Tiarawan Fadil C, S. Kep. Ns

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes